ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Talbi Yassine	**ID Patient :**	20260405-103
Genre :	Homme	**Durée enreg. :**	480 min
Âge :	NR	**Taille (cm) :**	176
Poids (kg) :	116	**IMC :**	37,4 (Obésité sévère)

Dr Bakha

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

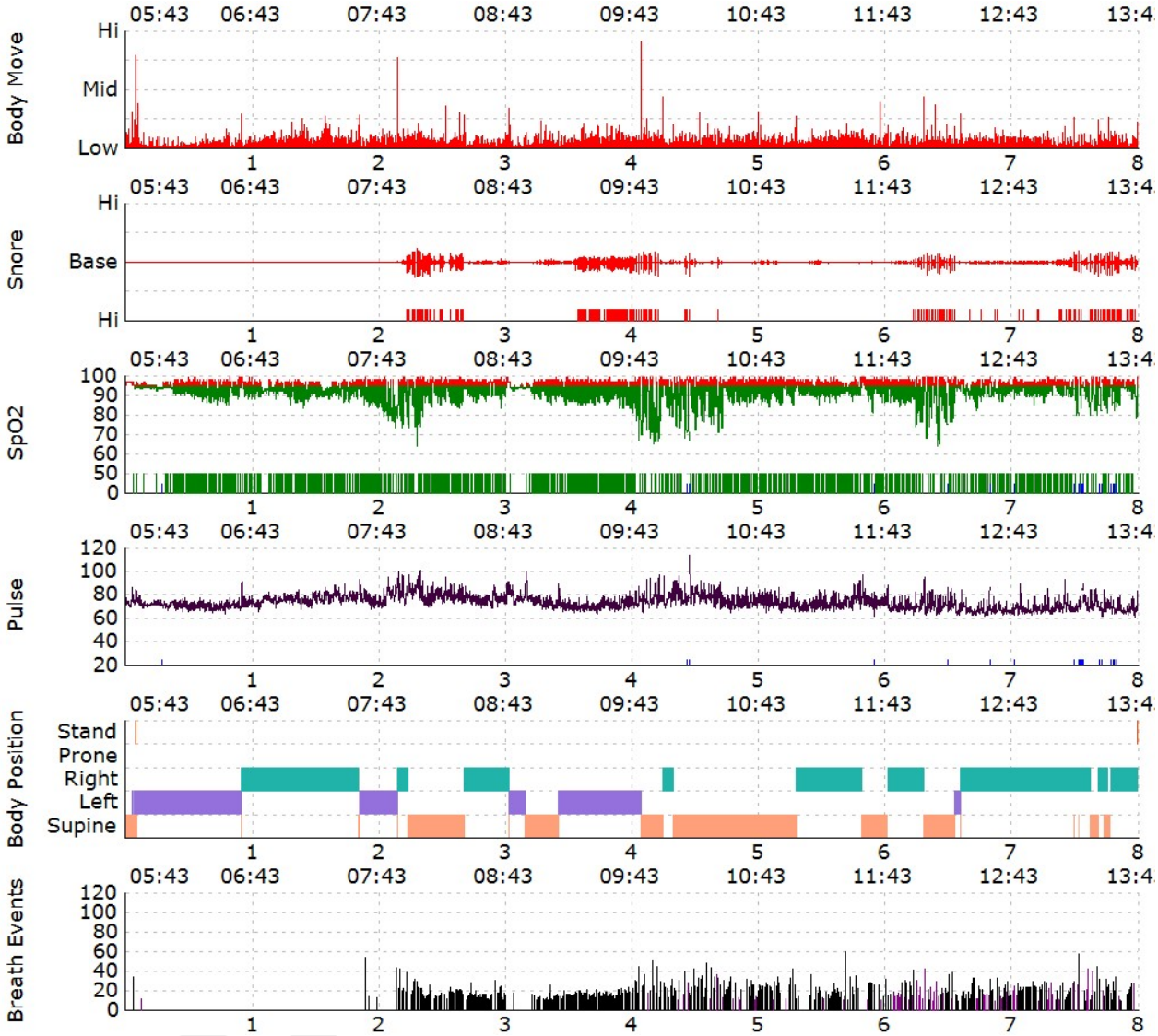

FIGURE 1 – **Analyse temporelle des données polygraphiques.**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

Table 1 – **Analyse des positions du corps et événements associés**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	149,0	31,0	158	25	0	0	200	383
Ventrale (PRO)	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Côté gauche (LAT-G)	118,1	24,6	80	1	0	0	172	253
Côté droit (LAT-D)	212,6	44,3	160	44	0	0	305	509
Debout	0,2	0,0	0	0	0	0	0	0

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2

Table 2 – **Analyse des événements de saturation en oxygène (SpO_2)**

Paramètre SpO_2	Valeur	Référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**64**	$\geq$ 90 %
SpO_2 moy (%)	**93**	$\geq$ 95 %
Durée DO (min)	316,5	—
IDO (/h)	**84,6**	$<$ 5 /h
Nombre DO	677	—
Durée $<$ 95% (min)	275,0	—
% $<$ 95%	57,7	$<$ 10 %
Durée $<$ 90% (min)	100,2	—
% $<$ 90%	21,0	$<$ 1 %
Durée $<$ 85% (min)	33,5	0 %
% $<$ 85%	7,0	0 %
Durée $<$ 80% (min)	16,2	0 %
% $<$ 80%	3,4	0 %

2.3. INFORMATIONS DU POULS

Table 3 – **Informations sur les mesures du pouls**

Paramètre Pouls	Valeur (bpm)
FC max	110
FC min	61
FC moy	74

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

Table 4 – **Analyse détaillée des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	70	
Durée totale (min)	20,6	
Durée moy (sec)	17,7	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	398	
Durée totale (min)	142,8	
Durée moy (sec)	21,5	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	468	—
Durée totale (min)	163,4	—
IAH	—	**58,5**
IDO	—	84,6
IMR (RDI)	—	58,5

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

Table 5 – **Résumé des informations principales de l'étude**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moy (%)	**93**	SpO_2 min (%)	**64**
IDO (/h)	84,6	Nombre SAOS	70
Nombre AC	0	Nombre AM	0
IA (/h)	8,8	Nombre HYPO	398
IH (/h)	49,8	**IAH (/h)**	**58,5**
IMR (/h)	58,5	Index Ronflements (/h)	37,1
FC moy (bpm)	74	Nb changements pos.	98

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation des Résultats

L'enregistrement polygraphique, d'une excellente durée de 480 minutes (8 heures), met en évidence les caractéristiques pathologiques suivantes :

— **Syndrome d'Apnées-Hypopnées du Sommeil (SAHS) :** L'Index d'Apnées-Hypopnées (IAH) global s'élève à **58,5 événements/heure**, ce qui définit un syndrome d'apnées du sommeil de degré **sévère** (IAH $\geq$ 30).

— **Profil des événements respiratoires :** On note une présence massive d'événements respiratoires (468 au total) avec une prédominance d'hypopnées (398) sur les apnées de type obstructif (70). Le patient passe plus de 163 minutes (soit plus de 2,5 heures) en événement respiratoire. On ne relève aucune apnée centrale.

— **Impact de la Position :** Le syndrome est présent dans **toutes les positions de sommeil**. S'il est particulièrement actif sur le côté droit et sur le dos, le décubitus latéral gauche ne permet pas de normaliser les indices (IAH $>$ 40 sur le côté gauche). Le SAOS n'est donc pas strictement positionnel.

— **Impact Oxymétrique Majeur :** Le retentissement sur l'oxygénation sanguine est très profond. La saturation moyenne de base est abaissée à 93%. L'Index de Désaturation en Oxygène (IDO) est extrêmement élevé à **84,6/h**. Le patient a présenté 677 micro-désaturations avec des chutes atteignant un seuil critique de **64 %**. Plus de 21 % du temps de sommeil se déroule avec une SpO_2 inférieure à 90 %.

— **Agitation et Ronflements :** Le tracé objective un index de ronflements très important (37,1/h), évocateur d'une forte résistance et obstruction des voies aériennes supérieures.

4.2. Conclusion Diagnostique

Le tracé est en faveur d'un **Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) Sévère**, non strictement positionnel, associé à de **très profondes désaturations nocturnes** (hypoxémie sévère) et à une intense activité de ronflement.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

— **Diagnostic :** SAOS Sévère avec hypoxémie nocturne profonde.

— **Mesures Hygiéno-Diététiques :** Prise en charge de l'obésité sévère (IMC : 37,4) par un suivi nutritionnel adapté pour favoriser la perte de poids, facteur d'amélioration du SAOS.

— **Thérapie de première intention :** L'appareillage par **Pression Positive Continue (PPC / CPAP)** est formellement indiqué en urgence au vu de la sévérité du syndrome (IAH $>$ 30) et du retentissement clinique potentiel (SpO_2 min : 64 %).

— **Suivi :** Une titration de la PPC est à programmer rapidement.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. S. Bakha